

TEMA 4.17 • GASTROENTEROLOGÍA

Hernia Hiatal, Hernia Diafragmática y Tumores del Mediastino

PERFIL EUNACOM 1.06.2.001
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Patología Perianal

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Truco EUNACOM: No leer rápido — **fisura ≠ fístula**. Son enfermedades distintas con manejos completamente diferentes.

Marco General

TABLA 4.17.1: PATOLOGÍA VS CLÍNICA PRINCIPAL

PATOLOGÍA	CLÍNICA PRINCIPAL	TRATAMIENTO
Fisura anal aguda	Dolor con defecación + rectorragia escasa	Baños de asiento + tratar constipación
Fisura anal crónica	Igual, > 6 semanas o recurrente	Baños de asiento + laxantes (+ cirugía si no responde)
Hemorroide externo trombosado	Dolor anal agudo, nódulo violáceo externo	Baños de asiento ± trombectomía (< 72 h)
Hemorroide interno	Sangrado sin dolor	Cirugía electiva (ligadura)
Prolapso hemorroidal	Hemorroides internos que salen por el ano	Grado 1-3: médico; Grado 4: cirugía electiva
Fruición hemorroidal	Hemorroides internos trombosados afuera, MUY dolorosos	Cirugía (urgente o electiva precoz)
Absceso perianal	Dolor creciente + masa eritematosa fluctuante	Drenaje quirúrgico en pabellón
Fístula anal	Absceso que drena por orificio a la piel	Cirugía (fistulectomía)
Absceso pelvirectal	Absceso perianal + sepsis + síntomas vesicales	Drenaje + antibióticos EV

1. Fisura Anal

Fisura Aguda

- **Causa:** estreñimiento → bolo fecal duro rasga el ano
- **Clínica:** dolor anal que inicia con la defecación + rectorragia escasa al papel
- El dolor persiste minutos post-defecación (espasmo del **esfínter interno**)
- **Diagnóstico:** inspección anal (se ve la fisura)
- **Tratamiento:**
 - **Baños de asiento** (calor húmedo → relaja el esfínter interno → cede el dolor)
 - Tratar constipación: dieta rica en fibra + agua

Fisura Crónica

- Misma clínica pero dura > **6 semanas** o recurrente
- **Tratamiento:** baños de asiento + **laxantes** (lactuosa o PEG) obligatorios
- Si no responde al tratamiento médico → **esfínterotomía lateral interna** (sección del esfínter **interno**)

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Siempre cortar el esfínter INTERNO, nunca el externo: - Interno = involuntario → produce el dolor y la isquemia (que impide cicatrizar)
- Externo = voluntario → si se corta → **incontinencia fecal**

2. Hemorroides

Hemorroide Externo Trombosado

- **Clínica:** dolor anal agudo (no necesariamente con la defecación), empeora al sentarse
- **Examen:** nódulo **violáceo** (trombo visible) en la zona **exterior** del ano
- No confundir con fruición: en el externo el nódulo está afuera de entrada, no protruye desde adentro
- **Tratamiento:**
 - **Baños de asiento** (siempre)
 - **Trombectomía** si lleva < 48-72 h (después ya no sirve)
 - **Complicación tardía:** puede dejar un **plicoma** (resto de piel → hallazgo benigno)

Hemorroides Internos

- **Clínica:** **hematoquecia SIN dolor** (sangran, no duelen)
- Son causa frecuente de HDB → siempre descartar otras causas (cáncer, diverticulosis)
- **Diagnóstico:** rectoscopia (objetiva y otras causas); idealmente colonoscopia completa
- **Tratamiento:** cirugía electiva (ligadura) + tratar constipación

Clasificación por Grado

TABLA 4.17.2: GRADO VS DESCRIPCIÓN

GRADO	DESCRIPCIÓN
I	No protruye; asintomático o sangrado
II	Protruye al defecar → se reduce solo
III	Protruye → requiere reducción manual
IV	Irreducible (sin dolor intenso = no es fruición)

Fruición Hemorroidal

- **Clínica:** hemorroides **internos** que atraviesan el ano, se **trombosan** y quedan afuera → **dolor intensísimo**
- Patología anal más dolorosa
- **Tratamiento:** cirugía (urgente o con tratamiento conservador previo 1-2 días para bajar inflamación)

3. Absceso Perianal

- **Clínica:** dolor anal que va **en aumento** (crece progresivamente, no súbito)
- **Examen:** masa eritematosa, **fluctuante** (no violácea como hemorroides)
- **Complicaciones:** fístula anal, absceso pelvirectal
- **Tratamiento:** drenaje quirúrgico **en pabellón** (no en box de urgencias)

EUNACOM CRITERIOS

Absceso perianal: no antibióticos solos. La evidencia muestra que los ATB no sustituyen el drenaje. El tratamiento es el **drenaje quirúrgico** sí o sí.

4. Fístula Anal

- **Definición:** absceso que drena a la piel formando un trayecto → se ve un orificio pequeño que supura
- El orificio puede estar lejos del absceso (el pus puede hacer un trayecto subcutáneo)
- **Diagnóstico:** clínico (orificio + pus + trayecto palpable)

- **Tratamiento:** cirugía (drenaje del absceso + resección del trayecto fistuloso)

5. Absceso Pelvirectal (= Absceso Isquioanal)

- Complicación grave del absceso perianal que se extiende hacia la pelvis
- **Clínica:** absceso perianal + **sepsis sistémica** (fiebre alta + compromiso del estado general) + **síntomas urinarios** (disuria, retención)
- **Diagnóstico diferencial:** prostatitis aguda (misma clínica → diferenciar por antecedentes)
- **Diagnóstico:** TAC o **RNM de pelvis** (obligatoria para ver extensión antes de cirugía)
- **Tratamiento:**
 - - Drenaje quirúrgico en pabellón
 - - **Antibióticos EV** (ceftriaxona + metronidazol) — a diferencia del absceso perianal simple, aquí **Sí** se agregan antibióticos

Resumen: ¿Cuándo operar?

TABLA 4.17.3: PATOLOGÍA VS URGENCIA QUIRÚRGICA	
PATOLOGÍA	URGENCIA QUIRÚRGICA
Fisura aguda/crónica	No (médico primero)
Hemorroide externo trombosado	No (trombectomía si < 72 h, pero no urgente)
Hemorroides internos	No (electiva)
Fruición hemorroidal	Sí (o electiva muy precoz)
Absceso perianal	Sí (drenaje en pabellón)
Fístula anal	Sí (electiva)

| Absceso pelvirectal | **Sí urgente** + antibióticos EV |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente con antecedente de trauma torácico hace 2 años. Radiografía de tórax muestra asas intestinales en hemitórax izquierdo. ¿Cuál es la conducta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Hernia Hiatal, Hernia Diafragmática y Tumores del Mediastino. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

- PUNTOS CLAVE DESTACADOS**
- Hernia diafragmática traumática: Rx tórax (asas en tórax); aguda=cirugía urgente, crónica=electiva
 - Hernia hiatal tipo 1 (>95%): no importa, tratar reflujo si lo hay
 - Hernia hiatal tipo 2 (<5%): hernia real con riesgo de complicaciones, cirugía
 - Tumores mediastino anterior: 4T = timoma, terrible linfoma, teratoma, tiroides
 - TAC de tórax: examen de elección para tumores del mediastino
 - Timoma: observar; si miastenia gravis asociada → cirugía

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (HERNIA HIATAL, HERNIA DIAFRAGMÁTICA Y TUMORES DEL MEDIASTINO)**PREGUNTA 1**

Paciente con antecedente de trauma torácico hace 2 años. Radiografía de tórax muestra asas intestinales en hemitórax izquierdo. ¿Cuál es la conducta?

- A)** Observación
- B)** Cirugía de urgencia
- C)** Cirugía electiva
- D)** TAC de tórax
- E)** Endoscopia digestiva alta

PREGUNTA 2

Paciente de 50 años con hallazgo incidental de hernia hiatal tipo 1 en endoscopia. No tiene síntomas de reflujo. ¿Cuál es la conducta?

- A)** Cirugía antirreflujo
- B)** Omeprazol profiláctico
- C)** Observación
- D)** Fundoplicatura de Nissen
- E)** pH-metría de 24 horas

PREGUNTA 3

En la radiografía de tórax se observa ensanchamiento del mediastino anterior. ¿Cuál es el examen a solicitar?

- A)** Ecografía torácica
- B)** RNM de tórax
- C)** TAC de tórax
- D)** PET-CT
- E)** Mediastinoscopia

RESUMEN: HERNIA HIATAL, HERNIA DIAFRAGMÁTICA Y TUMORES DEL MEDIASTINO

Clase sobre tres temas que aparecen como distractores. Hernia diafragmática traumática del adulto: diagnóstico con radiografía de tórax (asas en tórax), cirugía urgente en fase aguda, electiva en crónica. Hernia hiatal tipo 1 (deslizamiento, >95%): no importa, se trata el reflujo si lo hay. Tipo 2 (paraesofágica, <5%): hernia real, riesgo de complicaciones, cirugía. Tumores del mediastino: posterior = neurinomas (más frecuentes); medio = pericárdicos/bronquiales; anterior = 4T (timoma, terrible linfoma, teratoma, tiroides). TAC de tórax es el examen de elección. Timoma: observar salvo si asociado a miastenia gravis (cirugía).